

REPORT · 2026年4月

2026年第一季度神 经外科DRG运营分析 报告

title: 2026年第一季度神经外科DRG运营分析报告 type: 报告 tags: [报告, DRG, 神经外科, Q1, 2026] date: 2026-04-11

2026年第一季度神经外科DRG运营分析报告

本报告为基于知识库内容起草的示例报告，实际数据需根据2026年Q1真实数据填充。

一、概述

1.1 报告背景

神经外科是医院重要的高精尖科室，承担着颅脑肿瘤、脑血管病、脊柱脊髓等重大疾病的诊疗任务。本报告基于DRG分析框架，对2026年第一季度神经外科的运营绩效进行综合分析。

1.2 数据来源

- 病案首页数据（2026年Q1）
- 医保结算数据（2026年Q1）
- 参考：[[来源/20260411-神经外科DRG运营分析报告]]
- 参考：[[来源/20260114-神经外科住院绩效分析报告]]

二、能力分析

2.1 服务规模

指标	2026年Q1	2025年H2	同比变化
出院人次	[待填]	6,217	[待填]
手术人次	[待填]	4,024	[待填]
手术占比	[待填]	64.73%	[待填]
三四级手术占比	[待填]	77.49%	[待填]

2.2 技术难度（CMI分析）

指标	2026年Q1	2025年H2	说明
平均CMI	[待填]	3.93	神经外科CMI常年位于全院前列
CMI排名	[待填]	全院[待填]	高难度定位

RW难度分布（参考2025年H2数据）：

RW区间	人次占比	平均住院日	定位
[0, 0.50)	[待填]	[待填]	轻症病例
[0.50, 1.20)	[待填]	[待填]	中等难度
[1.20, 2.00)	[待填]	[待填]	较高难度
[2.00, 5.00)	**49.25%**	16.65	**核心病种区间**
[5.00, 10.00)	[待填]	[待填]	极高难度

关键洞察：近半数病例集中在RW≥2.0的高难度区间，体现神经外科"塔尖"定位。

2.3 费用与时间消耗指数

指标	2026年Q1	2025年参考值	全院均值
费用消耗指数	[待填]	1.03	1.00
时间消耗指数	[待填]	1.49	1.00

参考：[[概念/费用消耗指数与时间消耗指数]]

分析：神经外科费用消耗指数略高于全省平均，时间消耗指数偏高较多，提示需重点关注住院效率。

三、效率分析

3.1 住院效率

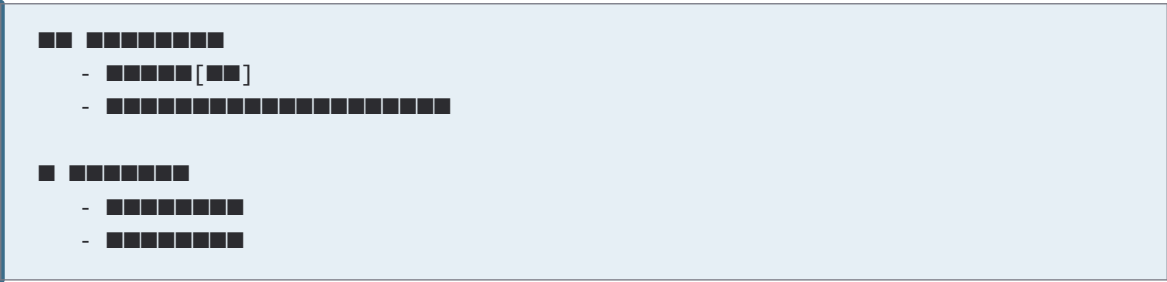
指标	2026年Q1	2025年参考	全院标杆
----	---------	---------	------

平均住院日	[待填]	[待填]	[待填]
床位使用率	[待填]	[待填]	[待填]
床位周转次数	[待填]	[待填]	[待填]

3.2 手术效率

指标	2026年Q1	2025年H2	变化
手术量	[待填]	4,024	[待填]
日间手术率	[待填]	[待填]	[待填]
微创手术率	[待填]	[待填]	[待填]
三四级手术率	[待填]	77.49%	[待填]

3.3 效率分析小结



四、质量分析

4.1 质量安全指标

指标	2026年Q1	参考值	判定
低风险组死亡率	[待填]	[待填]	[待填]
手术并发症率	[待填]	[待填]	[待填]
院内感染率	[待填]	[待填]	[待填]
非计划再次手术率	[待填]	[待填]	[待填]

4.2 再入院分析

指标	2026年Q1	说明
7天再入院率	[待填]	反映出院质量
14天再入院率	[待填]	反映综合救治水平
30天再入院率	[待填]	DRG质控重点

参考：[[概念/控制图]] — 可用于质量指标的时序监控

五、成本与盈亏分析

5.1 整体盈亏

指标	2026年Q1	2025年参考	变化
总盈亏（万元）	[待填]	-319.27	[待填]
病例数	[待填]	422	[待填]
平均盈亏（元）	[待填]	[待填]	[待填]

5.2 费用结构

费用项目	2026年Q1	占比	2025年参考	变化趋势
药品费	[待填]	[待填]	[待填]	[待填]
耗材费	[待填]	[待填]	[待填]	↑ 6.7%→9.7%
检查费	[待填]	[待填]	[待填]	[待填]
手术费	[待填]	[待填]	[待填]	[待填]
治疗费	[待填]	[待填]	[待填]	[待填]

5.3 高值耗材分析

耗材项目	金额（万元）	占比	趋势
颅内动脉瘤栓塞用电解脱弹簧圈	[待填]	[待填]	[待填]

其他高值耗材	[待填]	[待填]	[待填]
--------	------	------	------

关注点：耗材占比呈上升趋势（6.7%→9.7%），需加强管控。

5.4 病种盈亏结构

类别	数量	占比	说明
盈利病种	[待填]	[待填]	[待填]
亏损病种	[待填]	[待填]	[待填]
高倍率病例	[待填]	[待填]	主要亏损风险点

参考：[[概念/变异系数]] — 用于判断同病组费用离散程度

六、DRG价值矩阵分析

6.1 四象限分析

象限	特征	代表病种	策略
优势象限	高CMI、高盈利	神经介入检查术、伴创伤颅脑手术	重点发展，维持优势
效率象限	低CMI、高盈利	颅脑损伤不伴合并症	优化流程，提升效率
预警象限	高CMI、亏损	神经介入检查术(伴严重)、多发创伤开颅术	专项改进，特病单议
负担象限	低CMI、亏损	多发伤无手术等	评估价值，考虑转型

参考：[[概念/波士顿矩阵]] — 科室竞争力分析工具

6.2 帕累托分析

前25个病种覆盖80.3%病例，是重点管控对象。

排名	病种	病例占比	盈亏状态	优先级
1	[待填]	[待填]	[待填]	★★★
2	[待填]	[待填]	[待填]	★★★
3	[待填]	[待填]	[待填]	★★☆

七、医师绩效分析

7.1 医师绩效排名

类别	医师	病例数	平均CMI	平均盈亏（元）
CMI最高	[待填]	[待填]	[待填]	[待填]
盈亏最高	[待填]	[待填]	[待填]	[待填]
盈亏最低	[待填]	[待填]	[待填]	[待填]

7.2 同病同治分析

不同医师诊疗同一病种的费用差异，反映诊疗规范化程度。

病种	最高费用医师	最低费用医师	差异率
[待填]	[待填]	[待填]	[待填]

参考：[[来源/20260402-病种管理的标杆对比分析报告]] — 同病同治对比方法

八、主要问题与对策

8.1 重点问题识别

问题	严重程度	归因分析
时间消耗指数偏高	★★★	术前等待时间长、术后恢复慢
高倍率病例占比高	★★★	病种难度大、诊疗规范化不足
耗材占比上升	★★☆	高值耗材使用增加

医师间诊疗差异大	★★☆	同病同治推进不足
----------	-----	----------

8.2 管理建议

建议一：高倍率病例管控

- 1. 提前识别：建立高倍率预警机制，在住院过程中及时识别
- 2. 特病单议：符合条件的高倍率病例及时申报特病单议
- 3. 规范诊疗：减少不必要的检查和治疗，降低倍率

参考：[[概念/帕累托图]] — 用于识别主要亏损因素

建议二：效率提升

- 1. 优化术前流程：缩短术前检查等待时间
- 2. 加速术后康复：推广ERAS理念，缩短住院日
- 3. 日间手术转化：部分神经介入手术可考虑日间模式

参考：[[概念/控制图]] — 用于监控住院日趋势

建议三：耗材管控

- 1. 集采议价：对高值耗材开展集中采购
- 2. 使用标准：建立高值耗材使用标准和适应症规范
- 3. 监控预警：对耗材占比异常升高的医师开展点评

建议四：同病同治

- 1. 临床路径：对主要病种制定标准化临床路径
- 2. 费用对标：对比同一病种不同医师的费用差异
- 3. 原因分析：分析差异原因，针对性改进

九、总结

9.1 Q1工作成效

维度	评价
服务能力	[待填]

效率水平	[待填]
质量安全	[待填]
盈亏状况	[待填]

9.2 Q2工作重点

- 1. 控费攻坚：重点降低高倍率病例占比
- 2. 效率提升：缩短平均住院日，目标[待填]
- 3. 耗材管控：遏制耗材占比上升趋势
- 4. 同病同治：缩小医师间诊疗差异

附录

附录一：指标定义

指标	定义	参考来源
CMI	病例组合指数=总权重/总病例数	[[实体/CMI]]
费用消耗指数	该病组患者平均费用/全省平均	[[概念/费用消耗指数与时间消耗指数]]
时间消耗指数	该病组患者平均住院日/全省平均	[[概念/费用消耗指数与时间消耗指数]]
高倍率病例	实际费用/付费标准 > 1.5	[[概念/病种盈亏分析]]

附录二：分析方法

本报告采用的分析框架：[[方法论/DRG分析框架]]

可视化方法：

- [[概念/波士顿矩阵]] — DRG价值矩阵
- [[概念/箱线图]] — 费用异常值识别
- [[概念/帕累托图]] — 主要因素分析
- [[概念/控制图]] — 质量指标监控

报告生成日期：2026-04-11 基于知识库内容起草，实际数据需根据Q1真实数据填充